

当院の何がモラルディストレスを生んでいるか — 122人の面接が名指しした消費主義・医療階層・脱エスカレーションの構造不足(質的研究・JAMANetwOpen2025)

- 出典 Brender TD, Axelrod JK, Weiss Goitiandia S, Batten JN, Dzung EW. Clinicians' Perceptions About Institutional Factors in Moral Distress Related to Potentially Nonbeneficial Treatments. JAMA Netw Open. 2025;8(6):e2516089.
doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.16089
- 掲載誌 JAMA Network Open(2025-06-16)
- 原著 doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.16089(本文PDFは別途)
- 原題 Clinicians' Perceptions About Institutional Factors in Moral Distress Related to Potentially Nonbeneficial Treatments
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 本論文の使い方は「介入の献立表」ではなく「当院の自己診断票」。この論文が名指ししたのは、①医療消費主義を受け入れる病院文化、②医療階層を強化する構造、③脱エスケーレションを支える構造の不足、という3つの増悪因子である。まずこの3つに当院を照らし、どれが最も効いているかを決める
- 昨日読んだ [ICU看護師のモラルディストレス 34研究6461人 — プールMDS-R 49.98点・MMD-HP 88.32点、ただし統計処理に重大な疑義\(SR・メタ解析・BMCNurs2026\)](#) と完全に噛み合う。あちらの質的統合が示した組織要因(無益な延命治療の実施・人員不足・階層による発言力の欠如)に対し、本論文はその発生機序と、実際に効いた対抗手段を施設の言葉で名指しした。あちらの「何が起こっているか」に、こちらの「なぜ起きるか・どこを変えるか」が接続する
- 最も安く、最も早く効く一手は「看護師が単独で緩和ケア・倫理コンサルを起票できる権限」(原文 Q17)。ある施設では、以前は医師に怒鳴られるのを恐れて看護師が倫理コンサルを起票できなかったが、医師の許可を不要にした結果、看護師が自分でコンサルできるようになった。==当院の倫理係とERRS(Ethics Rapid Response System)は、この「起票権の所在」をどう書いているか。もし主治医の同意が事実上の前提になっているなら、そこが最大のボトルネックである==
- [ICU多職種カンファレンス\(運用と進行ガイド\)](#) は「開催されているか」ではなく「看護師が発言し、それが記録に残るか」で評価する。原文 Q23 の施設では、看護師リーダーが「30回の Goals of care 面談のうち看護師が同席したのは3回だった」という監査データを取り、それを持って上長に掛け合い、家族面談へのベッドサイド看護師の同席を必須化した。同じ監査は当院でも今週から取れる。ICテンプレート改訂の効果測定と同じ台帳に「面談時の看護師同席の有無」を1列足すだけでよい
- [ICテンプレート改訂\(3ステージプロトコル対応\)](#) には「脱エスケーレションの手順」を明記する。本論文の第3の増悪因子は、「治療を足す道はいくらでもあるのに、やめる道に明確な手続きがない」という非対称性だった(Q13)。当院のICテンプレートが「説明して同意を得る」方向にしか設計されていないなら、[終末期における時間制限つき治療トライアル\(TLT\) — 5要素と家族面談の進め方\(コメンタリー・JAMA2011\)](#) の5要素(何を・どの指標で・いつまで・改善したら／しなかったら何をするか)を組み込み、開始時に終了条件を書かせる形にすることが、そのまま脱エスケーレションの制度化になる

- 専門科コンサルタントとの非公式な階層は、当院でこそ効いている可能性が高い。本論文の新しい発見は、看護師対医師という古典的階層より、主科・集中治療医対専門科コンサルタント(腫瘍内科・外科)の力関係のほうに語られた点である。当院でも腫瘍・移植・外科系との間で同じ構図は容易に想像がつく。ICUの対立を課題・プロセス・関係の3層で読み解く — 「困った家族」の多くはプロセス不全の帰結(ナラティブレビュー・CritCare2026) の枠組みでいえばこれは「プロセス層」の問題であり、個人の説得力ではなく誰が最終的な治療方針を決めるかの取り決めで解く
- **Hotel ICU(★Hotel ICU Home)との接続点は「消費主義」の扱い**。本論文の Q4 は、患者をホテルやレストランの客のように扱う発想が「ノーと言えない文化」を生み、それが臨床医を傷つけると述べている。**当院の Hotel ICU は「ホテルのような快適さ」を掲げるが、本論文が批判する消費主義とは意図的に区別しなければならない**。当院が目指すのは「要求に応じる医療」ではなく「環境と体験の質を上げる医療」であること、そして**スタッフのWellbeingも同じ Hotel ICU の目的に含まれる**ことを、プロジェクト文書に明文化しておく価値がある
- **デブリーフィングは「死亡症例カンファ」ではなく「感情を扱う場」として設計する**。原文 Q20 の death rounds はインターン向けで、ICU での看取りの情緒的負荷を扱うことを目的としていた。当院の ICU退室後訪問 立ち上げ設計 や年1回の ICU改善アンケート と並べ、**難渋症例後48時間以内の短時間デブリーフを定例化する**(前掲メタ解析ノートの結論と同じ一手)
- **ただし「緩和ケアチームに全部投げる」は本論文自身が警告している**。緩和ケアの責務にスタッフのモラルディストレス対応まで加えることの財政的・倫理的帰結に注意せよ、と著者は述べ、代替として専任のモラルディストレス・コンサルテーションを挙げる。当院の緩和ケアチーム規模を考えると、**倫理係がその機能を持つほうが現実的**
- 看護師ファシリテーターはなぜ効かなかったか — 役割の曖昧さと縄張り(質的研究・ICM2024) と必ずセットで読む。あちらは「看護師に新しい役割を与えただけでは機能しない(役割が曖昧で縄張り争いになる)」ことを示した。本論文が挙げた成功例(起票権の付与・面談同席の必須化)は、いずれも**役割ではなく権限と手続きを変えている**点で決定的に異なる。当院で新しい係を作るときの分岐点はここにある



この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 重症患者の20～40%が終末期に潜在的に無益な生命維持治療(LST)を受けていると臨床医は認識しており、それがモラルディストレスの主要な源であることは繰り返し示されてきた。モラルディストレスは身体・精神の健康悪化、職務満足度の低下、バーンアウト、離職と関連する。施設要因(人員不足・高負荷・資源制約・ケアの配給・倫理風土)が関与することも量的研究で知られている
- **Unknown**: 施設要因が、社会レベルの要因(国の文化、地域・国の政策、医療階層)とどう相互作用してモラルディストレスに至るのかは、ほとんど検討されていなかった。また対策の大半が個人(マインドフルネス・レジリエンス・デブリーフィング)に向けられており、その偏りが根本原因から注意を逸らしている可能性が指摘されていた
- **What's new**: 4つの学術病院で122件の詳細面接を行い、**施設の文化と構造が、3つの社会的要因(高強度治療がデフォルトである軌道／医療消費主義／医療階層)の影響を増悪・予防・緩和する経路**を記述した。特に、①病院のマーケティングと評判が臨床実践と患者・家族の期待の両方を動かすこと、②看護師対医師だけでなく**主科医師対専門科コンサルタントという非公式な階層**がモラルディストレスを生むこと、③治療を足す手続きは豊富なのに減らす手続きがないという構造的非対称、の3点は新しい



全体要約

要旨

ひとことで 4病院122人の臨床医・管理者への面接から、モラルディストレスは個人の弱さではなく、**病院の文化と構造が「消費主義」「医療階層」「高強度治療のデフォルト」という社会的な力を増幅するか、逆に堰き止めるかで決まる**ことが示された。有効だったのは研修ではなく、**権限の再配分(看護師の単独コンサル起票権)**、**対立処理と情緒的支援の資源**、そして**現場発のQIを支持する管理職**である。

- **デザイン**: 質的研究(比較エスノグラフィー的手法)。半構造化・詳細面接を2018年2月～2022年6月に実施。COREQ 準拠

- **場**: 米国西海岸(カリフォルニア州・ワシントン州)の学術病院4施設。**終末期ケアの強度が異なる施設を Dartmouth Atlas に基づいて意図的に選定**
- **対象**: 122人(医師75人[61%]、看護師22人[18%]、診療看護師など advanced practice clinician 6人[6%]、チャプレン3人、文化メディエーター3人、ソーシャルワーカー4人ほか)。女性68人[56%]、平均年齢42歳(27~74歳)、平均経験年数15年(1~52年)
- **面接**: 平均・中央値とも47分(30~60分)。COVID-19 流行までは対面、以降はビデオ会議。録音・逐語化・匿名化。理論的飽和まで募集
- **解析**: 帰納・演繹を併用した line-by-line コーディングでコードブックを作成、**20%を二重コーディング**、不一致は合意まで討議。モラルディストレス関連コードを全抽出し、反証データでテーマを検証。ATLAS.ti 24.2.0。解析は2期(2019年1月~2022年12月、2024年6~9月)
- **増悪因子3テーマ**: ①医療消費主義の文化(マーケティング・評判・「顧客としての患者」)、②医療階層による拘束(看護師の排除/主科の専門科への従属)、③脱エスカレーションを支える institutional structure の不足(方針・手順の不在、倫理コンサルとリスクマネジメントの実効性の低さ)
- **予防・緩和因子3テーマ**: ④階層を越えて臨床医に権限を与える方針(看護師が単独で緩和ケア・倫理を起票できる)、⑤対立処理と情緒的支援の資源(文化メディエーター、緩和ケアチーム、death rounds、ワークショップ)、⑥現場発のQIと支持的な管理職(倫理リスクスコアが多職種回診への組み込み、家族面談への看護師同席の必須化)
- **著者の結論**: 個人向け介入ではなく、**施設ごとに仕立てた施設レベルの介入**(方針・資源配分・病院文化への働きかけ)が必要である

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **モラルディストレス(moral distress)**とは、Jameton が1984年に定義した概念で、「臨床医が自分の倫理的価値観に沿って行動できないと感じる状態。その原因が社会的・階層的・施設的な制約にあるとき」を指す。ここで重要なのは、「何が正しいか分からない」という迷い(**moral uncertainty**)ではなく、「正しいことは分かっているのに、それができない」という拘束の感覚である点。本論文は代替定義が多数提案されていることを認めたくえて、Jameton の原定義を採用している。

潜在的に無益な生命維持治療(potentially nonbeneficial life-sustaining treatments, LST)とは、人工呼吸・持続的腎代替療法・昇圧薬など、患者の最善の利益に資さない、あるいは害を与えると臨床医が判断する状況で継続される生命維持治療を指す。「無益(futile)」と断定せず「潜在的に無益」と留保した語を使うのは、無益性の判定自体が価値判断を含み、決着していないため。

本論文の骨組みは3つの層である。**社会的要因(societal factors)**=国の文化、地域・国の政策、医療階層のような、個々の病院の外側にある力。**施設要因(institutional factors)**=病院の文化(共有された信念・価値・慣行)と構造(方針・手順・資源配分)。**個人の体験(individual experience)**=実際に臨床医が感じる苦痛。著者の主張は「社会的要因は直接個人に届くのではなく、**病院という増幅器・減衰器を通して届く**」ということであり、だからこそ病院レベルで介入できる、という論理になっている。

もうひとつの鍵語が**医療消費主義(health care consumerism)**。医療パターナリズムへの対抗として「患者が自分の医療を決めるべきだ」という思想から出発したが、批判者は、それが医療の商品化と、無益な治療の要求を医師が断れなくなることによる professional integrity(専門職としての一貫性)の侵食を招くと論じてきた。本論文の回答者の語りは、この批判に実地の裏づけを与えている。

施設選定に使われた **Dartmouth Atlas** は、米国の医療資源の地域差を可視化した長年のプロジェクトで、終末期ケアの強度(死亡前6か月のICU日数、専門医受診回数、ホスピス利用など)を病院単位で比較できる。本研究はこれを使い、「終末期ケアの強度が異なる」施設を意図的に組み合わせた。

2. 背景と目的

臨床医は、重症患者の20～40%が終末期に潜在的に無益な LST を受けていると認識している。無益と感じる LST や他の高強度治療(例:終末期の化学療法)は臨床医のモラルディストレスの大きな源であり、その治療が患者の目標と乖離している(goal-discordant)と信じるときにさらに悪化する。

モラルディストレスを経験した臨床医は、患者ケアに悪影響が出ると自覚し、身体・精神の健康が悪く、職務満足度が低く、バーンアウト率が高く、職業を離れる可能性が高い。著者ら自身の先行研究では、モラルディストレ

スはバーンアウトの「倫理的な根本原因」と位置づけられており、医療従事者不足を踏まれば医療システムへの脅威でもある。

施設要因としては、人員不足、高い業務量、資源の制限、ケアの配給 (rationing)、病院の倫理風土 (ethical climate) が既に指摘されてきた。社会的要因としては、国の文化、地域・国の政策、そして**公式の階層 (看護師対医師) と非公式の階層 (診療科間)**がある。しかし、施設要因が社会的要因の影響をどう変換するのかについては、ほとんど分かっていなかった。

さらに著者は、これまでの対策が個人に偏っていることを問題視する。マインドフルネス訓練、個人のレジリエンス、デブリーフィングといった介入は、個人に焦点を当てるあまり、**根底にある施設の・社会的な原因に向けた解決策から注意を逸らしてしまうおそれがある。**

本研究は、著者らが先行研究で構築した「病院の文化と構造が終末期の高強度治療へのデフォルトの軌道を形づくる」というデータセットを用い、同じデータからモラルディストレスの根本原因を解析する二次解析として設計された。

3. 方法(Methods)

3-1. デザインと施設選定

- **デザイン**: 質的研究。著者は「comparative ethnographic methods (比較エスノグラフィー的手法)」を用いたと記載。実際に記述されているデータ収集は半構造化・詳細面接であり、面接の反復と施設間比較を通じてテーマを構築するアプローチ
- **期間**: 2018年2月～2022年6月 (COVID-19 流行を挟む4年4か月)
- **施設**: カリフォルニア州およびワシントン州の**学術病院4施設**
- **選定基準**: **Dartmouth Atlas によって特徴づけられた「終末期ケアの強度が異なること」を基準に施設を選定**。すなわち、施設間の文化差を最大化する目的的サンプリング (purposive sampling) である。ただし本文中に、各施設がどの強度区分に属するかの具体的な記載はない
- **倫理**: UCSF の IRB 承認。COVID-19 流行前は書面同意、流行中および以降は口頭同意

3-2. データ収集

項目	内容
面接者	E.W.D. (Dzeng、病院総合診療医かつ社会学者)が単独で実施
形式	半構造化・詳細面接 (semistructured, in-depth interviews)
媒体	COVID-19 流行までは対面、以降はビデオ会議
記録	録音、逐語化、匿名化
面接時間	平均・中央値とも47分 (範囲30～60分)
面接ガイド	全面接で同一のガイドを使用。臨床上の役割に応じて軽微に調整
進め方	開放型。回答者が最も関連すると考える話題を自由に話すよう促す。先行面接の分析から生まれたテーマとパターンを、後続面接で掘り下げる
募集	グループおよび個別のメール勧誘とスノーボール・サンプリング
参加率	算出不能 (未承諾のメール、メーリングリスト、直接勧誘を経由したため分母が定義できない)
飽和	理論的飽和 (theoretical saturation) に達するまで募集を継続。すなわち、面接がそれ以上の新しい洞察を生まなくなった時点で終了

対象は、病院を基盤とする救急科・内科・専門科の臨床医（看護師、病院総合診療医、集中治療医、緩和ケア医など）、病院のリーダー（病棟の看護管理者・診療科長など）、および臨床背景と職責の異なる管理者。人口統計学的情報、職種、経験年数は自己申告。人種・民族は、参加者の多様性を最大化する目的で収集された。

3-3. データ解析

解析とデータ収集は**並行かつ反復的**に行われた。手順は次のとおり。

段階	実施者	内容
① コードブック作成	J.N.B., E.W.D. ほか	面接の一部集合に対する主題分析。文献レビューと自グループの先行研究に基づき、帰納的・演繹的な line-by-line 解析 でコードを生成
② 二重コーディング	J.N.B. ほか	全面接の20%を二重コーディング し、コードブックをさらに精緻化
③ 不一致の解消	チーム	討議とコードの改訂を繰り返し、 合意 (consensus) に至るまで 継続
④ コード抽出	—	モラルディストレスに関連する すべてのコードを抽出 し、モラルディストレス・施設の文化と構造・終末期の社会的要因の関係を解明する対象とした
⑤ テーマ生成	T.D.B.	抽出コードを解析し、初期テーマを生成
⑥ テーマの検証	T.D.B., E.W.D., J.N.B., S.W.G., J.K.A. の5名	反証データ (counterfactual data) でテーマに挑戦し、反復的なチーム討議で合意に至るまで精緻化

ソフトウェアは ATLAS.ti version 24.2.0。解析は2期に分けて実施された(2019年1月～2022年12月、2024年6月～9月)。前期はデータ収集と並走した一次解析、後期がモラルディストレスに焦点を当てた本論文の解析にあたる。

信頼性の担保として記載されているもの: 20%の二重コーディング、合意に至るまでの討議、反証データによるテーマの検証、複数分析者(5名)による反復討議、COREQ 準拠の宣言。**記載されていないもの**: **member checking** (参加者への結果の返却確認)、**観察データや文書データとの triangulation** (三角測量)、**コーダー間一致率 (κ 等) の数値、面接ガイドの本文掲載、施設ごとのテーマ分布。**

3-4. 主要アウトカム

質的研究であるためアウトカムは数値ではなく、「臨床医が自施設の文化と構造について語ったこと、およびそれと終末期の潜在的に無益な LST に関するモラルディストレスの体験との関係」である。

4. 結果① — 対象の内訳 (Table 1)

Table 1. 面接対象者の属性 (N = 122)

属性	人数(%)
医師(全体)	75(61)
うち指導医(attending)	57(47)
うちフェロー	10(8)
うちレジデント	8(7)
専門別:救急科	10(13)
専門別:倫理	5(6)
専門別:老年科	3(4)
専門別:集中治療	29(37)
専門別:内科	23(29)
専門別:緩和ケア	8(10)
Advanced practice clinician	6(6)
看護師	22(18)
チャプレン	3(2)
文化メディエーター(cultural mediator)	3(3)
ソーシャルワーカー	4(3)
人種・民族:アジア系	25(20)
人種・民族:黒人・アフリカ系米国人	6(5)
人種・民族:ヒスパニック	7(6)
人種・民族:中東系	2(2)
人種・民族:複数民族	9(7)
人種・民族:白人	71(58)

属性	人数(%)
人種・民族:その他または未回答	2(2)
性別:男性	50(41)
性別:女性	68(56)
性別:その他または未回答	4(3)
年齢、平均(範囲)、歳	42(27～74)
就業経験、平均(範囲)、年	15(1～52)

職種の内訳で押さえるべき点は3つ。第一に、**集中治療医が医師の最多群(29人)**であり、ICU の文脈が語りの中心にあること。第二に、**看護師は22人(18%)にとどまる**こと。モラルディストレス文献の主役は一貫して看護師であることを踏まえると、この構成比は結果の重心を医師側に寄せうる。第三に、**文化メディエーターとチャプレンが対象に含まれている**こと。これが後述の「文化メディエーター」テーマの発見につながっている。

5. 結果② — 増悪因子1:医療消費主義(Health care consumerism)

回答者は、**医療システムのマーケティングと評判が、臨床医の診療パターンに影響する**と感じていた。広告や対外的メッセージが LST の使用を促しているという認識である。

- ある回答者は、著名な前 CEO のインタビュー発言(「うちでは人を死なせない」という趣旨)が今も語り草になっており、それが「人を死なせない」という病院文化そのものになっていると述べた(Q1、緩和ケア医、病院2)
- 別の回答者は、地域の広告看板に自院のがん医療が大々的に掲げられていることと、腫瘍内科医が終末期の患者にもがん治療を投与しようとする傾向とを結びつけて語った(Q2、レジデント、病院4)

これらはいずれも、潜在的に無益な LST や高強度治療の使用が増えることを通じて、**臨床医のモラルディストレスを悪化させると**受け止められていた。

マーケティングと評判は、患者・家族の期待も形づくる。ある回答者は、自院の標語(「可能を定義し直す」という趣旨)が「この病院なら必ず問題を解決してくれる」という期待を患者に与えていると述べ、解決できない問題に直面したとき、医療者の側が落胆・苛立ち・悲しみを抱え込むことになると説明した(Q3、病院総合診療医、病院1)。

さらに踏み込んだ語りが2つある。

- **患者を「商品の消費者」として捉える発想への批判。**ある管理者は、ホテルや遊園地やレストランのように運営できない場面があり、患者にとって正しくないことには「ノー」と言わなければならない、それをしないのは悪い医療だ、と述べた(Q4、患者体験担当管理者、病院2)。回答者はこの発想が有害だと考えており、その理由は、それが「臨床医が患者に『あなたはこの治療で利益を得られない』と言えない病院規範」を反映しているからである
- **家族の要求への追従がもたらす苦痛。**ある ICU 看護師は、家族が蘇生の継続を望むために肋骨が折れ出血する処置を続ける場面を挙げ、「家族が望むことを何であれ行うことが倫理的なのか」と問い、それが極度に苦痛であると述べた(Q5、ICU 看護師、病院2)

回答者は、患者・家族の治療強度への期待の高まりと、潜在的に無益な LST の使用増加とを結びつけ、それがモラルディストレスの体験に寄与すると捉えていた。

6. 結果③ — 増悪因子2:医療階層による拘束

(Medical hierarchies constrained clinicians)

このテーマは**2つの階層**からなる。片方は既知、もう片方が本論文の新規性である。

6-1. 看護師対医師(公式の階層)

医療階層のために、看護師は「潜在的に無益な LST の軌道を自分では変えられない」と認識し、それがモラルディストレスを増幅した。具体的には次の3つの場面である。

場面	語られた内容	引用
意見を求められない	医師が、その治療が医学的に有益か、患者の意向に沿っているかについて看護師の見解を尋ねない。看護師は「もっとコミュニケーションがあれば患者のためにもっと擁護できたのに」と感じ、それが大きなモラルディストレスになった	Q6 (ICU 看護師リーダー、病院2)
懸念が黙殺される	上申しても ICU のリーダーシップがそこから先へ進めてくれず、翌日出勤しても何も変わっていない。ICU での1日は患者の苦痛が1日延びることを意味する	Q7 (神経 ICU 看護師、病院1)
発言の負担が個人に乗る	看護師を日常的に議論へ含める文化がなく、看護師がしびれを切らして立ち上がり強く主張して初めて動く	Q8 (緩和ケア医、病院1)

Q8 が示しているのは重要な構造である。看護師が組織的に意思決定から排除されている病院文化では、**自分の見解を検討させるために、モラルディストレスを受けている当人が、階層の上位にいる医師に挑まなければならない**。苦痛を受けた者に、その苦痛を解消する労力まで負わせる設計になっている。

6-2. 主科医師対専門科コンサルタント(非公式の階層)

本論文の**最も新しい所見**がここにある。主科の医師(病院総合診療医、ICU 医師)もまた、専門科コンサルタント(腫瘍内科医、外科医)に対して自分たちが無力だと感じており、それがモラルディストレスにつながっていた。

- ある ICU 医師は、腫瘍領域の患者を診るよう求められると緊張を感じ、自分なら通常行わないより積極的なケアを提供するよう求められる、あるいは圧力をかけられると感じると述べた(Q9、ICU 医師、病院2)
- ある病院総合診療医は、家族が快適さ重視や治療の非拡大に関心を示していても、腫瘍科チームが話をすると予後不良にもかかわらず「全速前進」になってしまう、無益と感ずることをしていて患者本人の望みでもないかもしれないと感じるのは苛立たしい、と述べた(Q10、病院総合診療医、病院2)
- ある ICU 医師は、外科系専門科について、どんな治療が提示されるかを自分は制御できず、家族に問われても自分には何の権限もない、それは患者に対する真の残酷さの域に達しつつある、と述べた(Q11、ICU 医師、病院1)

著者はこの構図を、看護師対医師の階層とは**質的に異なる問題**として整理する。医師は伝統的階層において看護師より明確に上位にあるが、**診療科間の力関係は明示的でなく、力の差が制度に書かれていない**。書かれていないがゆえに、規則の改訂では解けない。

看護師と主科医師の双方について、モラルディストレスに寄与したのは2つの感覚だった。**他の臨床医によって拘束されているという感覚(Q6・Q7・Q11)と、潜在的に無益な LST の実施に加担しているという感覚(complicit)(Q7・Q9・Q11)である。**

7. 結果④ — 増悪因子3:脱エスカレーションを支える構造の不足

回答者は、患者が潜在的に無益な治療を受けているとき、**病院システムから支えられていないと感じていた。**

- ある緩和ケア医は、輸血・透析・経管栄養に依存し改善する見込みが極めて低い患者について、「何らかの方針か、システムが我々を助けてくれる仕組みがあればよかった。あまりにも不可能に感じられたから」と述べた(Q12、緩和ケア医、病院1)
- ある ICU 看護師は、構造的な非対称を的確に言語化した。**「コンサルトできる新しいチームは常にあり、試せる新しい救済療法も常にある。治療を足し、続けることには大きな勢いがあるのに、潜在的に無益な治療を中止したり差し控えたりする明確な機会や手続きは、それほど存在しないように見える」**(Q13、ICU 看護師、病院1)。そして「ある時点から、チーム内の情緒的な苦痛のほうに勢いをもち始める」と続く

つまり、**治療の追加には手続きが用意され、治療の減量には手続きが用意されていない**。この非対称そのものが増悪因子である。

さらに深刻なのは、**倫理コンサルテーションとリスクマネジメントという「本来この問題を扱うはずの資源」が実効性を持っていない**という語りである。

- 倫理コンサルトが役に立たないわけではないが、実際にはできること・言えることがそれほど無い場合がある (Q14、ICU 医師、病院3)
- リスクマネジメントを持ち出すことは「脅し」として機能し、倫理も同様で、家族と足並みを揃える助けにはならない (Q15、病院総合診療医、病院1)

著者はこれを、これらの資源が**逆説的に、医療チームと患者・家族の関係を悪化させう**ると要約している。倫理コンサルやリスク管理が「対立の道具」として認識されると、それを呼ぶこと自体が関係を壊す行為になってしまう。

8. 結果⑤ — 予防因子1:階層を越えて臨床医に権限を与える方針

ここからが「予防・緩和」側である。回答者が明確に肯定的に評価したのは、**看護師がモラルディストレスを感じたときに、独立して緩和ケアチームや倫理チームにコンサルトできる方針**だった。

- ある緩和ケア医は、自院では誰でも緩和ケアをコンサルトでき、チーム間の権限共有が大きく、それが看護師に力を与えたと述べた。その結果、必要だった会話がチームで持たれるようになり、ときにそれはモラルディストレスの表明そのものになる (Q16、緩和ケア医、病院3)
- ある ICU 看護師は変化の前後をこう語った。以前は医師に怒鳴られるのを恐れて倫理をコンサルトする看護師は誰もいなかった。今は医師の許可を得る必要がなく、倫理的ジレンダやモラルディストレスを感じたら、いつでも倫理をコンサルトできる (Q17、ICU 看護師、病院4)

著者はこの方針の作用機序を2つ挙げている。第一に、**看護師が医師との対立を迂回できる**こと (Q17)。対立を勝ち抜く必要がなく、別の経路が用意されている。第二に、**階層を越えた権限共有の病院文化を生み出す**こと (Q16)。方針が文化を作る、という方向の因果である。

考察では、この種の方針は「限られた資源をモラルディストレスの根本原因に向けて活用できる」と評価されている。加えて重要な非対称の指摘がある。**医師は技術的には無益な LST を脱エスカレーションできる立場にありながら、施設の構造が不十分であるために実際上は拘束されていると感じていた**。看護師の問題が「権限がない」ことなら、医師の問題は「権限はあるが支えがない」ことである。

9. 結果⑥ — 緩和因子:対立処理と情緒的支援の資源

9-1. 文化メディエーター (cultural mediator)

1施設が、臨床訓練を受けていない実務者である**文化メディエーター**を雇用していた。言語的・文化的背景(出身国、宗教など)の相違から生じる、臨床医・患者・家族の間の困難を扱う職種である。

回答者は、東アフリカ出身の患者の事例を挙げ、全員が集まって「患者が終着点に達しており、敬意をもって見送る時が来た」という理解に至る必要があったこと、そのとき文化メディエーターがいたことで、アムハラ語の言語通訳だけでなく、家族の信念に関する一般的な文化的課題までを橋渡しできたと述べた(Q18、ICU 医師、病院3)。

著者が強調するのは、文化メディエーターが果たした二方向の機能である。臨床医が患者・家族の文化に根ざした価値と信念をよりよく理解できるようになり、同時に、**なぜその LST が無益あるいは目標と乖離している**と考えるのかを臨床医が伝えられるようになった。単なる通訳ではなく、意味の翻訳である。

9-2. 緩和ケアチーム

回答者は緩和ケアチームを、潜在的に無益な LST が懸念されるときに使う施設資源として同定した。緩和ケアチームは、患者・家族が自分の価値観と意向を医療チームと話し合う機会を作った。

ある緩和ケア医は、コンサルトの理由がしばしば「医療者側のモラルディストレス」であること、すなわち医学的に正しいと思われることと、家族や患者が選択していることが食い違う状況であることを述べ、自分たちの役割は両方の視点を聴くこと、つまり**医療者には感じている苦痛を表明する機会を、家族や患者には自分が何者でどんな信念と価値を持つかを説明する機会を、それぞれ与えること**だと語った(Q19、緩和ケア医、病院3)。

緩和ケアチームと倫理コンサルトは、一部の臨床医にとって**モラルディストレスを吐き出す重要な出口**としても機能していた(Q16・Q17・Q19)。

9-3. デブリーフィングと情緒的支援

- **death rounds**(終末期ケアに関する組織化された討議)が月1回開催され、主にインターンに向けて、ICU で人を看取ることの情緒的ストレスを扱っていた。自分が納得できない、あるいは不適切だと考えるケアを提供することへの居心地の悪さに関連することもあり、それがストレスになる(Q20、ICU 医師、病院3)
- ソーシャルワーカーとチャプレンによる**看護師向けワークショップ**では、バーンアウトやモラルディストレスの原因となっている体験を匿名で共有でき、バーンアウトや共感疲労に対処する有用な戦略が教えられた(Q21、神経 ICU 看護師、病院1)

回答者は、これらの資源が**困難な体験と感情を扱う技法を参加者に教えた**と報告している。看護師と研修医という、階層の下位に位置し、かつ最も長時間ベッドサイドにいる層が主な対象になっている点は運用上の示唆になる。

10. 結果⑦ — 予防因子2:現場発のQIと支持的な管理職

このテーマには具体的で再現可能な2つの実例が含まれる。ジャーナルクラブで最も持ち帰りやすい部分である。

実例1:倫理リスクスコアを多職種回診に組み込む(Q22、ICU 看護師リーダー、病院2) ある部署は、初回記録に評価ツールを導入し、**倫理的ジレンマのリスクを「高・中・低」のスコアとして統合**した。これがチーム回診の一部になっていたため、肝移植チームとも連携できた。回答者はその効用を2点挙げている。第一に、看護師が新しい言語(倫理の言語)を学び、医師も同様に学んだこと。第二に、**スコアが十分に高い場合には自動的に医師の指導層へエスカレーションされる手順が作られたこと**。これは「気づいた個人が上申する」から「基準を満たしたら自動で上がる」への転換であり、Q8 が描いた「しびれを切らした看護師が立ち上がる」構造の裏返しになっている。

実例2:家族面談への看護師同席の必須化(Q23、ICU 看護師、病院4) ある看護師は自部署で監査を行い、**Goals of care と終末期に関する家族面談30回のうち、看護師が同席したのはわずか3回**であることを示した。そのデータを持ってリーダーシップに提示し、支持を得て、**病棟の方針を変更してベッドサイド看護師の家族面談同席を必須とした**。

実例3:層の積み重ねとしての文化(Q24、ICU 医師、病院1) 第三の回答者は、自院が医学的に有効でないと考えるケアを避けようとしており、極度に積極的なケアに至る他施設より慎重であると述べ、その功績を緩和ケアに帰した。そのうえで「それはすべての層(layers)から来ている」と表現し、事前ケア計画記録に関する取り組み、ICU でのコンフォートケア指針の再設計、看護師全体への影響、ICU の多職種回診を列挙した。すなわち、**病院文化は単一の施策ではなく、複数の小さな施策の積層から生まれる**。

著者はこれらの実例から共通項を抽出する。すなわち、**個々の課題を旗振りする臨床医の存在と、診療科リーダーシップの支持の組み合わせが、施設の構造と病院文化の変化を駆動する**(Q23・Q24)。

考察ではさらに踏み込んだ主張がある。**特定の介入がもたらす直接的効果を超えて、モラルディストレスの構造的原因に対処する方針を「同定し、設計し、実装する」というプロセス自体が、臨床医に力を与えるように見える**。何が実装されたかだけでなく、誰がそれを作ったかが効いている、という読みである。

11. 図 — 3層モデル

図の解説

Figure. 施設要因と社会的要因が、潜在的に無益な生命維持治療に関わるモラルディストレスにどう影響しうるか。図は入れ子の楕円で構成される。最も外側の楕円が全体場で、その左端に「Social factors (社会的要因)」として3項目が置かれる：消費主義、医療階層、高強度治療のデフォルト軌道。外側の楕円の内側に破線の楕円「Institutional factors (施設要因)」があり、その中に色分けされた3つのボックスが縦に並ぶ。上段の赤いボックスが「Exacerbating factors (増悪因子)」で、治療の脱エスカレーションを支える構造の不足、病院の文化と構造が医療階層を強化すること、医療消費主義を受け入れるマーケティング・評判・病院文化、の3項目。中段の淡黄色のボックスが「Preventative factors (予防因子)」で、階層を越えて臨床医に権限を与える方針、臨床医主導のQIと支持的な病院リーダーシップ、の2項目。下段の橙色のボックスが「Mitigating factors (緩和因子)」で、対立処理・デブリーフィング・情緒的支援の資源、の1項目。左の社会的要因から右へ向かって2本の太い白い矢印が伸び、いずれにも「Potentially nonbeneficial life-sustaining treatments (潜在的に無益な生命維持治療)」と記されている。上の矢印は赤い増悪因子のボックスを貫通して右端へ達し、下の矢印は淡黄色の予防因子のボックスを貫通するが右端の手前で縦棒に阻まれて止まっている。矢印の到達点である右端には青い円「Individual experience of moral distress (モラルディストレスの個人的体験)」が置かれ、下段の緩和因子のボックスからは細い曲線の矢印がこの青い円へ向かう。原図・無改変。

この図が伝える構造は、文章より明快である。読み取るべき点は4つ。

図の要素	意味すること
社会的要因が左端にある	消費主義・医療階層・高強度治療のデフォルトは、個々の病院が単独で消せる対象ではない
矢印が施設要因の層を「通過」する	社会的要因は直接個人に届かず、必ず病院という媒体を経由する。だから病院レベルで介入できる
予防因子の矢印が縦棒で止まる	予防因子は、モラルディストレスの体験に至る前に、無益な LST の流れそのものを堰き止める
緩和因子だけが青い円に直接つながる	緩和因子は流れを止めない。すでに生じたモラルディストレスの体験に作用する

つまり、**予防 (prevention) と緩和 (mitigation) は同じ「対策」ではない**。方針と権限の設計は上流を止め、デブリーフィングと情緒的支援は下流を和らげる。当院で「デブリーフィングを始めました」だけで終わると、上流は流れ続けたままになる。

12. 考察 — 著者の議論

12-1. 消費主義について

消費主義は医療パターナリズムへの対抗として、消費者(すなわち患者)が自分の医療の決定を統御すべきだと主張する立場である。批判者は、それが医療の商品化と、潜在的に無益な治療の要求を医師が拒否できなくなることによる**専門職としての一貫性 (professional integrity) の侵食**を招くと論じてきた。本研究の臨床医の語りはこの見方と一致し、**患者の選好が臨床医の推奨を上回るものとして扱われる病院文化**を描いていた。無益な LST の要求を断れないと感じたとき、彼らはモラルディストレスを経験した。

12-2. 医療階層について

医療階層は多くのモラルディストレス定義の構成要素である。看護師が意思決定から排除されることによるモラルディストレスは文献で広く記述されており、看護師の**構造的な無力化 (structural disempowerment)**をさらに進める可能性がある。

本研究が浮かび上がらせたのは、そこまで認識されていない別の要素、すなわち**主科医師と専門科コンサルタント医師の間の力の不均衡**である。医師が伝統的階層で看護師の上位にあることは明確だが、診療科の異なる医師間の力の差はより不明瞭である。主科の医師は、コンサルタントが潜在的に無益な LST を含む臨床上の軌道を決めたときに、拘束され、モラルディストレスを経験すると述べた。

12-3. 増悪の連鎖

著者は、施設要因がどのように社会的3要因を相互強化して増悪させるかを次のように描く。マーケティングと資源配分の決定(例:がんセンターへの資金投入)は、患者と家族が高強度治療を期待できる施設としての評判を強める。この力学は、消費主義が病院の文化と構造に及ぼす拘束的影響を反映している可能性がある。そしてマーケティング・評判・資源は、**専門科医師が潜在的に無益な治療を実施することを促し、非公式な医療階層の中で主科医師を無力化する病院文化に寄与する**。

12-4. 何が対策になるか

- **看護師の権限**: 緩和ケアと倫理へのコンサルトを看護師に許すことは、看護師を意思決定に参加させ、無力感とそれに伴うモラルディストレスを減らした。この種の方針は、限られた資源をモラルディストレスの根本原因に振り向けることを可能にする
- **非公式階層への別のアプローチ**: 看護師対医師の公式な力の不均衡とは異なり、主科医師が専門科コンサルタントに対して経験する非公式な階層的拘束には、別の手法が必要になる。**施設要因を考慮せずにチーム内コミュニケーションの改善だけを目指す戦略は、限られた成果しか生まないおそれがある**

- **プロセス自体の効果**: 構造的原因に対処する方針を同定・設計・実装するプロセスそのものが臨床医に力を与えるように見える。病院のリーダーは、方針を改善し臨床医の懸念に応答的な病院文化を作るために、**臨床医主導の QI を支える方法を検討する**
- **緩和ケアの拡大には注意**: 緩和ケアチームの責務がモラルディストレスへの対処にまで拡大する場合、患者と臨床医にとっての財政的・倫理的な帰結に慎重な注意が必要である。代替として、**専任のモラルディストレス・コンサルテーションサービス**が臨床医を支援する
- **施設ごとの仕立て**: 多様で医療資源に恵まれない患者集団を診る施設の回答者は、文化メディエーターの役割を挙げた。何が有効かは施設の患者集団に依存する

13. 限界(著者の記載+読み手としての追加)

著者が明記した限界は2点のみである。

- ① 臨床医と施設に影響しうる社会的・施設的要因は他にもありうるが、それらを回答者の一般的な認識を超えて明示的に検討することはできなかった
- ② 観察は都市部の、資源の豊富な学術医療センター4施設に基づいており、農村部・低資源・非学術病院には一般化できない可能性がある

読み手として追加すべき限界は次のとおり。ジャーナルクラブの論点になる。

限界	なぜ問題か
米国の文脈依存性	「医療消費主義」「マーケティング」「がんセンターへの資金投入」は、出来高払いと病院間競争、訴訟環境を前提とする。日本の診療報酬体系と広告規制の下では、同じ強度で作動しない可能性がある
二次解析である	元のデータセットは「終末期の高強度治療への軌道」を主題として収集・コーディングされた。モラルディストレスに関するコードを事後に全抽出する設計であり、 モラルディストレスそのものを直接掘り下げる質問が最適化されていない 可能性がある
面接期間が COVID-19 を跨ぐ	2018年2月～2022年6月は、ICU の倫理環境が最も激しく変動した時期である。かつ 面接媒体が対面からビデオ会議へ変わっている 。パンデミック前後でテーマがどう変化したかの解析は示されていない
面接者が単独	全面接を1名(病院総合診療医かつ社会学者)が実施している。深さの一貫性という利点はあるが、面接者の立場性 (positionality) が語りに与えた影響の考察が示されていない
募集バイアス	スノーボール・サンプリングとメール勧誘であり、 参加率は算出不能 。この主題に既に強い関心と問題意識を持つ人が集まりやすい
看護師の比率	122人中22人(18%)。モラルディストレス文献の中心である看護師の声が、医師(61%)より小さく反映されている
施設ごとの分布が示されない	4施設は終末期ケアの強度が異なるという理由で選ばれたのに、 各施設がどの強度に位置するか、どのテーマがどの施設に多かったかの対応表がない 。比較エスノグラフィーを名乗る以上、この比較こそが読みたい部分である
member checking と triangulation の不在	参加者への結果返却、観察データ・文書データとの照合の記載がない。COREQ 準拠を宣言している以上、該当項目の充足状況は気になる
「comparative ethnographic methods」の実質	記述されているデータ収集は面接のみである。参与観察や現場の文書分析があったのかは本文からは読み取れない

14. 批判的吟味(JCでの論点)

論点1: Table 1 の数字が合わない 職種の行を合計すると $75+6+22+3+3+4 = 113$ 人であり、 $N = 122$ に9人足りない(パーセントの合計も93%)。抄録と引用には「administrators(管理者)」が含まれ、実際に Q4 は患者体験担当管理者の発言だが、**Table 1 に管理者の行がない**。表が対象全体を記述していない。

論点2: 専門別の分母が医師数と一致しない 専門別の内訳は $10+5+3+29+23+8 = 78$ で、医師75人を3人超える。パーセント(集中治療37%、内科29%、緩和ケア10%、救急13%、倫理6%、老年4%)を逆算すると分母は78であり、75ではない。二重専門の重複計上と思われるが、その注記がない。

論点3: 本文の引用番号が表を取り違えている 結果の「予防因子1」の記述で、Q16 を参照する箇所が **Table 2** と書かれているが、Q16 は Table 3 に収載されている。校正上の誤りだが、引用先の表が2つある論文で読者を迷わせる。

論点4: 質的研究として、有効性の主張はどこまで言えるか Q22(倫理リスクスコア)と Q23(看護師同席の必須化)は魅力的な実例だが、**いずれも当事者の自己申告であり、モラルディストレスが実際に減ったかを測る指標は取られていない**。「回答者はそう感じた」以上の主張はできない。ジャーナルクラブでは、この2施策を当院で導入する場合の**測定計画**(MMD-HP の反復測定、離職意向、面談同席率)をセットで議論すべきである。

論点5: 倫理コンサルトが「役に立たない」という所見の扱い Q14・Q15 は、倫理コンサルテーションとリスクマネジメントが実効性を欠き、逆効果になりうると述べている。一方で Q16・Q17・Q19 では、倫理コンサルトが看護師の重要な出口として機能している。**同じ資源が、起票権と運用の設計次第で正反対に働く**という読み方が最も整合的だが、著者はこの対比を明示的には論じていない。ここは当院の倫理係設計に直結する論点である。

論点6: 「消費主義」という語の射程 本論文は消費主義を主に負の力として描くが、その出発点は患者の自己決定権の擁護である。**患者中心のケアと消費主義の境界をどこに引くか**は本論文では未解決のまま残る。この線引きを誤ると、「本人の意向を尊重する」という当院の方針が「要求に応じる」とことと混同されうる。

論点7: 本人が語れることの限界 モラルディストレスは主観的体験であり、面接で得られるのは「本人がそう認識している因果」である。マーケティングが本当に処方行動を変えたのか、それとも臨床医がそう帰属しているだけなのかは、この設計では区別できない。著者もこれを「perceptions」と題に明記して留保している。

15. 昨日読んだメタ解析との対比 — どちらを当院で使うか

ICU看護師のモラルディストレス 34研究6461人 — プールMDS-R 49.98点・MMD-HP 88.32点、ただし統計処理に重大な疑義(SR・メタ解析・BMCNurs2026) と本論文は、同じ主題に対して正反対の方法で接近している。並べると使い分けが明確になる。

論点	メタ解析(BMC Nurs 2026)	本論文(JAMA Netw Open 2025)
方法	34研究6,461人の混合研究法レビュー。量的プールと質的統合	4施設122人の質的研究(半構造化面接)
対象職種	ICU 看護師のみ	医師61%・看護師18%・管理者・チャプレン・文化メディエーターなど多職種
答え ている 問い	「どれくらい強いか」「どんな要因が何研究で言及されたか」	「なぜ起きるか」「病院の何を変えると変わるか」
数値 の信 頼性	プール値は標準偏差を標準誤差として入力しており、フォレストプロットの研究名と数値も取り違えられている。 49.98/88.32 は引用に耐えない	数値は属性記述のみ。プール推定を行わないため、統計処理の誤りが結論を汚染する余地がない
使える 部分	質的統合(体験・要因・対処の3層マップ)と 要因の頻度分布 。質問票設計に流用できる	テーマ全体。特に 増悪因子3つと有効だった施策3つ
実装 への 距離	遠い。「組織要因が主因」までは分かるが、何を変えるかは書かれていない	近い。起票権・面談同席・リスクスコアという 手続きレベルの記述 がある
当院 への 一般 化	14か国の看護師データであり、日本の研究も含まれる。文化的射程は広い	米国西海岸の学術病院4施設。 消費主義とマーケティングの部分 は日本にそのままは移らない

結論として、当院で「次の一手」を決めるために使うのは本論文である。理由は3つ。第一に、メタ解析の数値部分が引用に耐えないのに対し、本論文はもともとプール推定をしないため、方法上の脆さの種類が違う。第二に、メタ解析が示したのは「組織要因が主因である」という**方向**までであり、本論文が示したのは「どの制度をどう変えたか」という**手続き**である。第三に、メタ解析が挙げた組織要因の上位(無益な延命治療の実施、階層による発言力の欠如)と、本論文の増悪因子(脱エスカレーション構造の不足、医療階層)が**そのまま対応している**ため、両者を重ねると「頻度で優先順位をつけ、手続きで解く」という設計ができる。

ただし**測定にはメタ解析側を使う**。当院でモラルディストレスを測るなら MMD-HP(27項目・離職意向の設問つき)が現実的な選択で、その項目リストと要因の頻度分布は前掲ノートに整理済みである。**測るのはメタ解析側、変えるのは本論文側**、という役割分担が最も無駄がない。

16. 主要な引用文献一覧

番号	内容	著者・雑誌・年
3	ICU における無益と認識された治療の頻度とコスト	Huynh TN, et al. JAMA Intern Med. 2013;173(20):1887-1894
4	欧州・イスラエルの ICU 看護師と医師によるケアの適切性の認識 (APPROPRICUS)	Piers RD, Azoulay E, et al. JAMA. 2011;306(24):2694-2703
5	終末期の病院における非有益治療の範囲に関するシステムティックレビュー	Cardona-Morrell M, et al. Int J Qual Health Care. 2016;28(4):456-469
8	終末期の無益な治療に関する米国研修医のモラルディストレス (質的研究)	Dzeng E, et al. J Gen Intern Med. 2016;31(1):93-99
9	モラルディストレスの原定義	Jameton A. Nursing Practice: The Ethical Issues. Prentice Hall; 1984
12	ICU におけるモラルディストレスの帰結 (質的研究)	Henrich NJ, Dodek PM, et al. Am J Crit Care. 2017;26(4):e48-e57
15	モラルディストレスとして我々は何を測っているのか (定義の批判的検討)	Kolbe L, de Melo-Martin I. Am J Bioeth. 2023;23(4):46-58
21	対立する倫理 — バーンアウトの根本原因としてのモラルディストレス	Dzeng E, Wachter RM. J Gen Intern Med. 2020;35(2):409-411
25	看護師のモラルディストレスの量的文献レビュー	Oh Y, Gastmans C. Nurs Ethics. 2015;22(1):15-31
26	医師のモラルディストレスに関する系統的スコーピングレビュー	Quek CWN, et al. BMJ Open. 2022;12(9):e064029
28	終末期の DNR 意思決定に対する施設文化と方針の影響	Dzeng E, et al. JAMA Intern Med. 2015;175(5):812-819
30	倫理風土・モラルディストレス・バーンアウトを理解する概念枠組み	Dzeng E, Curtis JR. BMJ Qual Saf. 2018;27(10):766-770
32	3つの学術医療センターにおける病院文化と終末期ケアの強度 (本研究の母体データ)	Dzeng E, Batten JN, et al. JAMA Intern Med. 2023;183(8):839-848
33	欧州 ICU 看護師の専門職自律性・医師との協働・モラルディストレス	Papathanassoglou EDE, et al. Am J Crit Care. 2012;21(2):e41-e52

番号	内容	著者・雑誌・年
37	術後の Goals of care をめぐる外科医と集中治療医の対立	Paul Olson TJ, et al. JAMA Surg. 2013;148(1):29-35
38	「それは平行宇宙だ」— 外科医と集中治療医のコミュニケーション分析	Haas B, et al. Crit Care Med. 2015;43(10):2147-2154
45	モラルディストレスの systemic な根本原因を認識する	Weiss Goitiandia S, et al. Am J Bioeth. 2024;24(12):29-32
46	施設選定に用いた終末期ケア強度のデータ源	Dartmouth Atlas Project. Dartmouth Atlas: end of life care
49	何件の面接で飽和するか(データ飽和の実験)	Guest G, Bunce A, Johnson L. Field Methods. 2006;18(1):59-82
51	患者中心のケアはよい、しかし患者を消費者とすることは違う	Gusmano MK, et al. Health Aff (Millwood). 2019;38(3):368-373
53	MMD-HP(医療者用モラルディストレス尺度)の開発	Epstein EG, et al. AJOB Empir Bioeth. 2019;10(2):113-124
54	ICU における看護師と医師の視点 — 協働・モラルディストレス・倫理風土	Hamric AB, Blackhall LJ. Crit Care Med. 2007;35(2):422-429
56	臨床医の苦痛に対する緩和ケアコンサルトは職務の一部か	Schenker Y, Rosa WE, Arnold RM. J Pain Symptom Manage. 2024;68(6):641-646
57	医療システム全体を対象としたモラルディストレス・コンサルテーションの開発と評価	Hamric AB, Epstein EG. HEC Forum. 2017;29(2):127-143

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 モラルディストレスは臨床医個人の脆さではなく、**病院の文化と構造が「消費主義」「医療階層」「高強度治療のデフォルト」という社会的な力を増幅した結果**である。4施設122人の面接が名指しした増悪因子は、①ノーと言えない病院文化を生むマーケティングと評判、②看護師を排除し主科を専門科に従属させる階層、③**治療を足す手続きは豊富なのに、減らす手続きが用意されていないという構造的非対称**、の3つだった。

明日から当院で変えられるのは3点。①**看護師が主治医の許可なしに倫理・緩和ケアを起票できるようにする**（原文で最も明確に効いた施策）、②**Goals of care 面談へのベッドサイド看護師の同席率をまず監査し、必須化する**（ある施設は30回中3回という実測値を武器に方針を変えた）、③**ICテンプレートに「終了条件」を書かせて脱エスカレーションを手続き化する**。

レジリエンス研修とデブリーフィングは「緩和因子」であって「予防因子」ではない。図が示すとおり、それらは苦痛が生じた後に作用するだけで、上流の流れは止めない。**個人向け介入から始めると、根本原因から注意が逸れるという著者の警告そのものになる**。

昨日のメタ解析との使い分けは明快である。**測るのはメタ解析側（MMD-HP の項目と要因の頻度分布）、変えるのは本論文側（起票権・同席・終了条件という手続き）**。